

Anamnèse générale

1) Anamnèse actuelle et caractérisation de la plainte

- Pour une douleur
 - Localisation
 - Irradiation
 - Intensité (y.c. fluctuation de l'intensité)
 - Qualité (caractérisation)
 - Timing (début et évolution dans le temps)
 - Facteurs modifiants (soulageants et aggravants)
 - Symptômes associés
- Pour une autre plainte (ex. vomissements, diarrhées, etc.) → toujours caractériser +++
 - Fréquence, timing, etc.
 - Couleur / texture
 - Sang
- Pour un état fébrile → insister sur pattern (ex. évolution temporelle / au cours de la journée)
- Questions bonus :
 - *Avez-vous déjà eu un épisode similaire ?*
 - *Avez-vous déjà fait des examens / traitements pour cela ?*
 - *Qu'est-ce qui vous inquiète / dérange le plus par rapport à vos symptômes ?*

2) Questions spécifiques au système concerné

3) Questions générales (= rechercher des symptômes B)

- Fièvre avec température précise, méthode de mesure, timing/schéma, frissons associés
- Sudations nocturnes
- Perte de poids
- Fatigue

4) Anamnèse par système – rapidement, de la tête aux pieds

- Neuro → céphalées, vertiges
- Cardio → palpitations, œdèmes
- Pneumo → toux, dyspnée
- Gastro → douleurs, vomissements, selles (fréquence, odeur, couleur, sang, mucus, etc.)
- Urines → odeur, couleur, sang, fréquence, etc.
- Sexuel → partenaire sexuel, contraception, protection IST
- Ostéoarticulaire → douleurs articulaires et osseuses
- Dermato → changement au niveau de la peau

5) Histoire médicale personnelle

- ATCD médicaux et chirurgicaux (insister diabète, HTA, hypercholestérolémie, IR)
- *Avez-vous été malade récemment ?*
- Traitements (y.c. auto-médication, pilule contraceptive, plantes, vitamines, etc.)
- Vaccination
- Allergies

6) Histoire familiale (notamment parents, fratries, enfants)

7) Habitudes

- *Question n°1 → dans la vie de tous les jours, vous sentez-vous en bonne santé ?*
- Alimentation
- Tabac / alcool / drogues
- Activité physique
- Activité sexuelle
- Voyage
- Animaux
- Vie familiale (rechercher stress)
- Vie professionnelle (rechercher stress et risques liés à l'environnement)
- Loisirs / activités particulières
- (En cas de bilan de santé → pourriez-vous me décrire une journée type ?)

8) Y a-t-il encore quelque chose que j'aurais besoin de savoir pour mieux vous prendre en charge ?

Caractérisation des principaux symptômes

Pour tout symptôme = timing (début, aigu vs. graduel, durée, progression, évolution, intermittent vs. continu)

<i>Symptômes généraux</i>	
Douleur	Localisation et irradiation, qualité, intensité (y.c. fluctuation), timing et évolution dans le temps, facteurs soulageant, facteurs aggravants, traitements essayés, symptômes associés
Fatigue	Caractériser fatigue, sommeil, conséquences de la fatigue Ad. recherche dyspnée (anémie), hypothyroïdisme (constipation, prise de poids, intolérance au froid), dépression, diabète (polyurie, polydipsie), autres symptômes associés
<i>Système nerveux</i>	
Céphalées	Caractérisation de la douleur Ad. recherche méningisme → rash, fièvre, raideur de nuque Ad. recherche de Horton → troubles visuels, claudication, sensibilité scalp Ad. recherche de glaucome → troubles visuels, yeux rouges, halos autour des lumières Ad. recherche d'histoire de cancer Ad. recherche d'autres symptômes neurologiques
Faiblesse musculaire	Pattern, timing, caractérisation, fatigabilité, autres symptômes neurologiques
Syncope / chute	Circonstances, prodromes, durée, PC, mouvements/myoclonies, incontinence, morsure de langue, phase post-critique (amnésie, douleurs, confusion, etc.), ATCD d'épisodes similaires, autres symptômes neurologiques, autres symptômes cardio-vasculaires
<i>Système cardio-respiratoire</i>	
Dyspnée	Caractérisation, tolérance à l'effort, facteurs soulageant, orthopnée, DPN, variations journalières (en particulier diurne vs. nocturne), variations saisonnières, autres symptômes cardio-respiratoires, obstruction nasale, dysphagie, dysphonie, goitre thyroïdien
Toux	Productive vs. non-productive, caractérisation de l'expectoration (quantité, fréquence, couleur, consistance, sang), hémoptysie (volume, sang frais vs. altéré, fréquence), facteurs déclenchant, toux nocturne, autres symptômes cardio-respiratoires
Palpitations	Vitesse (lente vs. rapide), régularité (régulier vs. irrégulier), étourdissement, PC, N/V, sudations, dyspnée, autres symptômes cardio-respiratoires
<i>Système digestif</i>	
Vomissements, diarrhées, constipation	Quantité, fréquence, caractérisation (sang, mucus, bile), anorexie, perte de poids, régime et alimentation, signes d'anémie, autres symptômes gastro-intestinaux
Dysphagie	Type (solide vs. liquide), constante vs. intermittente, progressive vs. non-progressive, odynophagie, perte de poids, déficits neurologiques, autres symptômes gastro-intestinaux
Dyspepsie / brûlures d'estomac	Caractérisation de la douleur et recherche d'autres symptômes gastro-intestinaux
<i>Système ostéo-articulaire</i>	
Lombalgie	Caractérisation de la douleur, raideur, déformation, sciatique, incontinence Ad. recherche red-flags → fièvre, perte poids, cancer, déficit neuro, infection, immunosup. Ad. recherche d'autres symptômes neurologiques
Douleur articulaire	Caractérisation de la douleur, pattern mécanique vs. inflammatoire (jour/nuit, matin/soir, dérouillage matinale, impact du repos et de l'activité, caractère positionnel), impact sur le sommeil, perte de fonction / restriction de mouvement / perte de force, raideur, gonflement, recherche de symptômes neurologiques (faiblesse, paresthésie, engourdissement), recherche de troubles vasculaires
<i>Divers</i>	
Rash	Localisation, caractérisation, taille, forme, durée, progression, fréquence, grattage, douleur, facteurs modifiants (chaleur, froid, soleil, etc.), traitements déjà tentés, recherche d'autres symptômes (en particulier rhumatologiques)

Anamnèse par système détaillée

Anamnèse générale	- symptômes B - changements au niveau cutané - EG → 5A : apathie, asthénie, anorexie, amaigrissement, apyrexie <i>TOUJOURS RECHERCHER DES SYMPTÔMES ASSOCIÉS</i>
Anamnèse neurologique	- céphalées, raideur de nuque, photophonophobie - étourdissement, vertiges, équilibre, syncopes, chutes - vision / audition - pertes de mémoire / aspect cognitif - crises convulsives - faiblesse musculaire, engourdissement, fourmillement, hypoesthésie, etc. - incontinence urinaire et fécale, dysfonction érectile
Anamnèse ORL	- O : audition, tinnitus, otalgie - R : rhinorrhée, épistaxis - L : odynophagie, maux de gorge
Anamnèse CV	- douleur thoracique - dyspnée, cyanose - OMI - palpitations, syncope - FRCV : tabac, LDL, diabète, HTA, ATCD familiaux, sédentarité
Anamnèse respiratoire	- dyspnée à caractériser +++ - toux (aiguë vs. subaiguë vs. chronique) - expectorations / hémoptysie - douleurs (ex. pleuro-pulmonaires) - ronflements / somnolence
Anamnèse GI	- dysphagie - N/V - dyspepsie / brûlures d'estomac / régurgitations - douleurs abdominales - changements dans le transit, description des selles, sang et mucus dans les selles - perte de poids, changements dans l'alimentation - ictère → urines foncées + selles décolorées - input-output • Dernier repas • Nausées/vomissements, selles/gaz, urines, pertes vaginales et règles - ATCD de chirurgie abdominale (brides?)
Anamnèse urologique	- fréquence, volume, urgenturie / nycturie, impériosité, miction en 2 temps - signes d'infection → pollakiurie, dysurie, hématurie - mauvais flux urinaire, sensation de vidange incomplète - demander comment la miction se déroule - incontinence (médicaments, maladie neuro, ATCD, facteurs déclenchants)
Anamnèse gynécologique	- saignements (ménorragie, métrorragie, post-coïtal, post-ménopause) + écoulements - douleurs (y.c. dysménorrhée et dyspareunie) - grossesse → bien investiguer !
Anamnèse ortho-rhumato	- articulations → douleurs, raideur, gonflement, limitation mouvement, limitation force • Inflammatoire → nocturne, au repos, raideur matinale, amélioration via activité • Mécanique → diurne, à l'activité, dérouillage sans raideur - symptômes mécaniques → verrouillage, limitations, etc. - symptômes neurologiques → faiblesse, engourdissement, paresthésies - irradiation distale, distinction douleurs antérieures et postérieures - étendre anamnèse vers les autres systèmes dans les problèmes rhumatologiques ! • Peau (rash, ulcères, Raynaud) • Alopecie • Yeux / bouche (rougeur, sécheresse oculaire et buccale) • Dyspnée • Symptômes GI • Symptômes GU, en particulier écoulements - ATCD OA et autres (ex. maladies systémiques) + rechercher autres symptômes !

Anamnèse sexuelle	1) Caractériser le trouble sexuel • Contexte / comment cela a commencé • Fréquence / variations • Durée / intensité • Facteurs atténuants et aggravants • Conséquences 2) Contexte • Partenaire et pratiques • Regard / confiance en soi et sur autrui • Comment se passe l'intimité • Désir d'enfants et contraception • Communication générale et sexuelle au sein du couple • Situation générale du couple 3) Biographie du patient • Famille et enfance, éducation, religion, culture • Traumatismes • Développement sexuel et puberté • Premiers contacts intimes • Grossesse et avortements • Expérience et satisfaction • Relations extra-conjugales • Autres plaisirs (non-sexuels) DD : • Troubles du désir ◦ Anhédonie (tr. sexuel, tr. psy, post-naissance, maladies somatiques, médicaments) ◦ Hypersexualité (manie, borderline, anti-parkinsoniens) ◦ Aversion (dégoût, traumatisme, problème durant le développement) • Troubles de l'excitation ◦ F → ↓ lubrification, dyspareunie, facteurs psy, relations, ménopause ◦ H → dysfonction érectile (! CV) • Troubles du plaisir ◦ Anorgasmie ◦ Éjaculation précoce ou tardive (moyenne 6 min) ◦ Troubles érectiles (peurs, addictions, pornographie) ◦ Dyspareunie ◦ Vaginisme (abus, peur de la grossesse, lutte de pouvoir au sein du couple)
Anamnèse pédiatrique	Identique à l'adulte, avec en plus : • Demander au parent comment il trouve l'enfant • Insister sur l'alimentation (type de lait, quantités, transit, etc.) • Insister sur le comportement (joue normalement?) • Croissance et développement ◦ Transferts, assis, locomotion, marche 10-18 mois, préférence manuelle ◦ Sourire, curieux, doudou, opposition, séparation aisée ◦ Regarde mains, permanence de l'objet, puzzles, formes, contage, imitations ◦ Vocalises, 1^{er} mot, phrase, 50 % compréhensible, bégaiement physiologique • Vitamine K, vitamine D, régimes particuliers, etc. • Grossesse, naissance, ATCD médicaux • Vaccins + allergies • Fratrie, contage (crèche, école, etc.), animaux • Prévention maltraitance, tabagisme passif Devant des pleurs : laisser parler +++, demander si les pleurs sont inhabituels, examen clinique tête aux pieds, inspection du pampers, orienter DD selon red-flags • Irritabilité + pleurs ≠ coliques (le plus souvent) • Investiguer psychosocial (ex. dépression post-partum, SBS) • Suspecter allergies notamment si modification de l'alimentation Adolescent – HEAADSSS → Habitat, Éducation, Alimentation, Activités, Drogues, Sexualité, Santé mentale et suicide, Sécurité

Status cardio-vasculaire

Anamnèse – rappel :

- FRCV → tabac, LDL, diabète, HTA, ATCD familiaux
- Symptômes → douleurs thoraciques, dyspnée, œdèmes, palpitations, syncope

Status :

- Inspection :
 - Recherche ICG → cyanose (extrémités + langue)
 - Recherche ICD → turgescence jugulaire, OMI
 - Observation des mains (cyanose, signes d'endocardite, hippocratisme digital)
 - Asymétrie / déformation du thorax
 - Anomalies cutanées (ex. cicatrices, varices, etc.)
- Palpation :
 - TRC (N < 2 secondes)
 - Température cutanée (avec le dos de la main, comparer D-G au niveau des mains et des pieds)
 - Mesure de la FC sur 15 secondes (60 secondes si irrégulier)
 - Mesure de la FR
 - Palpation des pouls :
 - Carotidien
 - MS → brachial, radial, ulnaire
 - MI → fémoral, poplité, tibial postérieur, pédieux
 - Palpation du thorax à la recherche d'un frémitus et du choc de pointe (décubitus latéral G si nécessaire)
 - Reflux hépato-jugulaire (appuyer sur le foie 20 secondes)
 - Palpation des œdèmes si présents (godet?)
 - Ad. mesure TA si nécessaire ± recherche d'une hypotension orthostatique en levant le patient
- Auscultation :
 - Auscultation carotidienne (en apnée) + fémorale
 - Auscultation cardiaque (4 foyers) ± à l'inspiration profonde
 - ± ad. auscultation du foyer mitral en décubitus latéral gauche → sténose mitrale ?
 - ± ad. auscultation para-sternale gauche avec patient assis penché en avant et en expiration
 - Auscultation pulmonaire (signes d'IC?)

Bruits cardiaques	
B1	Fermeture valves AV, son long et grave, surtout apex
B2	Fermeture valves A/P, son court et aigu, surtout base
B3 (après B2)	Physiologique chez l'enfant et le jeune adulte Surcharge volumique ventriculaire (ICC)
B4 (avant B1)	Toujours pathologique, par exemple CMH
Souffles	
Souffles holosystoliques - insuffisance mitrale - insuffisance tricuspidienn - CIV	Souffle à l'apex irradiant dans l'aisselle gauche Souffle au niveau tricuspide irradiant au xyphoïde Souffle en parasternal gauche à irradiation étendue
Souffles mésosystoliques - souffles physiologiques - sténose aortique - sténose pulmonaire - CMHO	Souffle au foyer aortique irradiant dans carotides Souffle au foyer pulmonaire irradiant dans l'épaule G Souffle en parasternal gauche irradiant le long du sternum
Souffles diastoliques - insuffisance aortique - sténose mitrale	Souffle protodiastolique au foyer aortique Souffle méso-télédiastolique avec click, à l'apex

Status pulmonaire

Anamnèse – rappel :

- Dyspnée à caractériser (NYHA, bruits particuliers, etc.)
- Fièvre, toux, expectorations, hémoptysie, douleurs, ronflements, somnolence

Status – patient couché sur le dos :

- Inspection :
 - Rechercher SDR → stridor, sibilance, mm. accessoires, cyanose, etc.
 - Rechercher :
 - Signes d'hypoxémie (cyanose doigts / langue, hippocratisme digital)
 - Signes d'hypercapnie (transpiration scalp, confusion)
 - Observation du thorax (asymétrie, déformation, etc.)
 - Observation des mouvements respiratoires (les mouvements abdominaux doivent prédominer)
 - Mesure de la FR
- Palpation :
 - Palpation de toute zone douloureuse ou anomalie visible sur le thorax
 - Palpation des aires ganglionnaires (sous-mandibulaire, jugulaire, sus-clav, axillaire, coude, etc.)
 - Ampliation thoracique (mains sur le rebord inférieur des côtes)
- Percussion :
 - Délimitation des poumons
 - D → percuter le long de la LMC jusqu'à la matité hépatique
 - G → percuter le long de la LMC jusqu'au tympanisme gastrique (piège : matité cardiaque)
 - Percussion symétrique des poumons pour comparer les sons perçus
- Auscultation (demander au patient de respirer la bouche ouverte)
 - Bruit trachéal + 4 niveaux antérieurement + 2 niveaux latéralement, symétriquement
 - Ad. demander de tousser pour caractérisation des bruits

Status – patient assis :

- Inspection :
 - Observation du thorax et des mouvements respiratoires
- Palpation :
 - Palpation de toute zone douloureuse ou anomalie visible sur le thorax
 - Ampliation thoracique (mains sur le dos, en entourant la cage thoracique)
- Percussion :
 - Délimitation des poumons (transition avec les loges rénales)
 - Percussion symétrique des poumons pour comparer les sons perçus
- Auscultation (demander au patient de respirer la bouche ouverte)
 - 4 niveaux, symétriquement
 - Ad. demander de tousser pour caractérisation des bruits

Bruits pulmonaires	
Bruit trachéal, bruit trachéo-bronchique, murmure vésiculaire	Physiologiques
Souffle tubaire	Pneumonie
Crépitants fins	Alvéolite, fibrose, œdème
Crépitants grossiers	Sécrétions bronchiques
Sibilants	Obstruction / asthme
Ronchis	Bronchite / asthme

Status abdominal

Quadrants : hypochondre D/G, épigastrique, lombaire D/G, ombilical, iliaque D/G, sus-pubien

Anamnèse – rappel :

- Caractérisation de la douleur
- Fièvre, fatigue, modification de l'appétit, perte/prise de poids, régurgitations, transit, vertiges
- Ictère, selles décolorées, urines foncées
- Input-output (alimentation, dernier repas, N/V, gaz, selles, urines, pertes vaginales, règles)
- Rapports sexuels
- ATCD de chirurgie abdominale

Status :

- Inspection :
 - Aspect général de l'abdomen, asymétrie, voussure, demander au patient si ventre comme d'habitude
 - Rechercher anomalies cutanées y.c. cicatrices, hernies, etc.
 - Observation des mouvements respiratoires, recherche de mouvements pulsatiles
- Auscultation :
 - Auscultation 4 quadrants, en terminant par la zone douloureuse
 - Auscultation du trajet de l'aorte ± aa. rénales ± aa. iliaques à la recherche d'un souffle
- Percussion :
 - Percussion des 4 quadrants
 - Délimitation de la taille du foie le long de la LMC
- Palpation :
 - Palpation superficielle de l'abdomen (mise en confiance du patient)
 - Palpation profonde de l'abdomen (recherche de masse)
 - Recherche défense-détente
 - TR
- Examen des organes abdominaux :

Foie / vésicule biliaire	Palpation bimanuelle du foie (main D sous les côtes, main G derrière cage thoracique) Signe de Murphy (demander une inspiration profonde!)
Rate	Essayer de palper la rate de la même manière que le foie
Appendice	Signe de McBurney → palpation au niveau de l'appendice Signe du Psoas → flexion de la hanche jambe tendue contre résistance Signe de Rovsing → douleur en FID lors d'une détente en FIG
Rein	Percussion de la loge rénale en position assise
Uretères	Palpation du trajet des uretères à la recherche d'une douleur
Aorte	Essayer de palper l'aorte (à 2 mains)
Hernies	Demander au patient de lever la tête ou de tousser Si hernie → réductible ? strangulation ?

Complément – proctologie :

- Anamnèse → plaintes du patient à caractériser + investiguer les selles (fréquence, texture, sang, etc.)
- Status
 - Inspection (peau, souillures des sous-vêtements, fissure, marisque, thrombose, abcès, selles, etc.)
 - Demander au patient de pousser en fermant l'anus
 - TR → rechercher masse, selles, signes au niveau de la prostate et signes sphinctériens

Status neurologique

Anamnèse – rappel :

- Céphalées à caractériser +++ , vision, audition, vertiges, équilibre, N/V, photo-phonophobie, fièvre, épilepsie
- Troubles moteurs, troubles sensitifs
- Fonctions cognitives
- Cervelet → alcool, médicament, FRCV (AVC), SEP, trauma, cancer, hypothyroïdie, B1, vit. E, infections

Status :

- Nerfs crâniens

n. olfactif (I)	Demander au patient s'il reconnaît les odeurs
n. optique (II)	AV → lecture de textes, un œil après l'autre Champs visuels → fermer le même œil que le patient et chiffres avec doigts Pupilles → réflexe photo-moteur et d'accommodation-convergence + FO
n. oculomoteur, trochléaire, abducens (III,IV,VI)	Demander de fixer un stylo, puis tester la poursuite oculaire Investiguer les saccades (demander de regarder nez puis stylo puis nez etc.)
n. trijumeau (V)	Sensibilité du visage via toucher-piquer Palpation de l'ATM ± réflexe masséter Réflexe cornéen
n. facial (VII)	Demander au patient de froncer / lever les sourcils, de fermer les yeux, montrer dents
n. vestibulo-cochléaire (VIII)	Chuchotement en demandant au patient de se boucher une oreille, Weber, Rinné Test d'Halmagy (tourner brusquement tête du patient en demandant une fixation)
n. glosso-pharyngien et vague (IX, X)	Rechercher une déviation de la luette / voile du palais Palpation des cartilages thyroïdes durant une déglutition
n. accessoire (XI)	Demander de lever les épaules et de lever la tête contre résistance
n. hypoglosse (XII)	Demander de tirer la langue puis de faire des mouvements de langue

- Système somato-sensoriel
 - Commencer par tester globalement en effleurant la peau ; ajouter autres tests si anomalies ou suspicion ++
 - Toucher-piquer (les yeux fermés!)
 - Propioception (plier les doigts et les orteils et demander quel orteil est mobilisé)
 - Pallesthésie (déposer le diapason vibrant sur le styloïde du radius et la malléole interne)
 - Température
 - Stéréognosie (demander au patient d'identifier un objet placé dans sa main)
 - Graphesthésie (demander au patient de reconnaître un chiffre dessiné sur sa paume de main)
- Réflexes (toujours 2-3x, toujours bilatéral, cotation 0 à 4+, N = 2+, ad. manœuvre de facilitation si nécessaire)
 - MS → biceps (C5-C6), triceps (C7), brachio-radial (C6)
 - MI → quadriceps (L4), achillien (S1)
 - Réflexes cutanés (en position couchée) → réflexe cutané abdominal et réflexe cutané plantaire
- Système moteur
 - Inspection des loges musculaires MS + MI à la recherche d'une amyotrophie ou d'une déformation
 - Évaluation de la force (notation M0-M5)
 - MS → RE, abduction, F-E de l'avant-bras, du poignet et des doigts, abduction des doigts, pince
 - MI → flexion de la cuisse, extension de la jambe, flexion de la jambe
 - Patient couché → F-E du pied, F-E des orteils
 - Évaluation de la motilité fine en demandant au patient de pianoter avec ses doigts + orteils
 - Évaluation du tonus (via mobilisation passive) → nuque, épaule, coude, poignet, hanche, genou, cheville
- Épreuves cérébelleuses
 - Funambule puis Romberg (talons joints, bras tendus, puis fermer les yeux)
 - Épreuve doigt-nez (yeux ouverts puis fermés)
 - Épreuve talon-genou (yeux ouverts puis fermés, le patient doit descendre le talon jusqu'au pied)
 - Épreuve du rebond (flexion du bras contre résistance, lâcher d'un coup sans prévenir, doit s'arrêter)
 - Épreuve des marionnettes (lentement puis rapidement), puis taper sa cuisse en alternant paume/dos main
- Épreuves fonctionnelles
 - Signes de Lasègue et de Lasègue inversé (→ recherche une douleur en soulevant la jambe)
 - Épreuve des jambes fléchies
 - Mingazzini (patient sur le dos, demander une flexion des jambes à 90° pendant 15 secondes)
 - Barré (patient sur le ventre, demander une flexion des jambes à 90° pendant 15 secondes)
 - Épreuve des bras tendus (bras tendus en supination, yeux ouverts puis yeux fermés, 15 secondes)
 - Gowers (demander de s'accroupir et se relever sans les mains)
 - Marche (normalement, sur la pointe des pieds, sur les talons)
- Recherche de méningisme
 - Causes principales → méningite, HSA
 - Anamnèse → céphalées, douleurs nucales, photosensibilité, N/V
 - Status :
 - Raideur de nuque, fièvre, altération du status mental
 - Signe de Kernig (extension du genou durant une flexion de la hanche = douleur au dos)
 - Signe de Brudzinski (flexion de la nuque = flexion des jambes)
 - Signe de Jolt (douleurs lors de mouvements de la tête sur le plan horizontal)

Status ophtalmologique et ORL (vision, audition, sphère ORL)

Anamnèse – rappel :

- Ophtalmo → timing/évolution des symptômes, ATCD de symptômes oculaires, douleurs, sécrétions, rougeur, modifications de l'AV, flashes lumineux, corps flottants, diplopie, perte de vision périphérique
- ORL :
 - O → otalgie, otorrhée, acouphènes, hypoacousie, vertiges
 - R → rhinorrhée, épistaxis, odorat, obstruction nasale, douleurs sinusales
 - L → dysphagie, odynophagie (pharyngée vs. œsophagienne), dysphonie, fausses routes, tuméfactions

Status ophtalmologique :

- Inspection de la conjonctive (tirer paupière vers le bas et demander mouvements oculaires dans tous les sens, puis tirer paupière supérieure vers le haut et demander des mouvements oculaires dans tous les sens)
- Éversion de la paupière supérieure
- Examen du champ visuel (un œil après l'autre, 4 quadrants, demander au patient de fixer son nez)
 - Avec des chiffres
 - Avec des mouvements de doigts
- Examen de l'oculomotricité
 - Demander de regarder dans toutes les directions
 - Demander au patient de fixer un point
 - Demander au patient de suivre un stylo dans toutes les directions
 - Demander de fixer en alternance un stylo et son nez, de manière à évaluer les saccades (allers-retours)
 - Réflexe d'accommodation-convergence
- Examen des pupilles :
 - Réflexe photomoteur (ipsi + controlatéral)
 - Test de la lumière d'alternance (si neuropathie optique → dilatation à l'éclairage de la pupille)
- Acuité visuelle (un œil après l'autre) → vision de près (40 cm) puis vision de loin ; avec les lunettes
- Vision des couleurs (Ishihara, un œil après l'autre)
- Fond d'œil par ophtalmoscopie directe

Status ORL :

- Palpation cervicale (chaînes jugulaires, chaînes sous-mandibulaires, chaîne spinale, chaîne sus-clav, thyroïde)
- Inspection buccale (ouverture bouche, mobilité de la langue, dessous la langue, sillons, dents, oropharynx)
- Laryngoscopie indirecte
 - Saisir la langue avec une compresse et introduire le miroir → base de la langue, épiglotte, valécules
 - Demander de dire « iiiiiiiii » → ascension du larynx, fermeture glottique, exposition cordes vocales
 - Visualisation des margelles laryngées, des aryténoïdes et des sinus piriformes
- Inspection du nez
- Inspection de l'oreille
 - Mobilisation de l'oreille, palpation du tragus, palpation mastoïdienne
 - Otoscopie
 - Acoumétrie (voix chuchotée, Rinné, Weber)
- Examen oto-neurologique :
 - Otoscopie
 - Weber/Rinné
 - Évaluation des nerfs crâniens
 - Épreuve doigt-nez, épreuve des marionnettes, Romberg
 - Marche (y.c. sur la pointe et sur les talons)
 - Recherche de nystagmus, Hallpike, Halmagyi

Status de l'appareil urinaire et gynécologique

Appareil urinaire :

- Le plus important = investigation du pattern des mictions et de l'aspect des urines !
- Haut appareil urinaire (reins, uretères)
 - Anamnèse → douleurs lombaires, fièvre, hématurie, anurie, pollakiurie, etc.
 - Status → palpation + percussion
- Bas appareil urinaire (vessie, prostate, utérus)
 - Anamnèse
 - Obstruction (dysurie, latence mictionnelle, jet affaibli, miction en 2 temps, vidange incomplète)
 - Irritation (nycturie, pollakiurie, impériosité)
 - Incontinence (urgence vs. effort, médicaments, troubles neuro, facteurs déclenchants)
 - Status :
 - Palpation de la vessie
 - TR (en particulier pour la prostate)
- OGE masculins
 - Palpations des testicules et inspection de leur position, ad. transillumination si nécessaire
 - Torsion à suspecter si douleur brutale, position horizontale, Prehn neg, perte réflexe crémasterien
CAVE toujours rechercher une torsion pour les douleurs abdominales basses !

Gynécologie :

- Anamnèse
 - Caractérisation des plaintes
 - Grossesse
 - Seins (demander uni/bilatéral!) → masse, boule, écoulement, rougeur, ATCD, Hx familiale
 - Cycle menstruel → DDR, régularité, autres plaintes
- Status des seins
 - Position assise
 - Inspection (thorax, plaques, comparaison de volume, régularité des contours, bosses, rétractions, etc.)
 - Inspection sous traction musculaire (idem, mais patiente avec mains sur hanche et buste en avant)
 - Mobilité (demander à la patiente de mettre les mains derrière la tête et observer mobilité)
 - Palpation des 4 quadrants + prolongement axillaire avec la pulpe des 3 doigts du milieu + palpation de haut en bas en partant de la clavicule
 - Position couchée
 - Inspection (idem, se concentrer sur les quadrants inférieurs)
 - Palpation
 - Palpation centripète en ramenant les doigts vers soi, en palpant la gauche des seins si à droite
 - Palpation en quadrillage (d'abord en transversal, puis en crânio-caudal)
 - Rechercher un écoulement par pincement (demander à la patiente de le faire)
 - Palpation des ganglions lymphatiques, comme dans un status pulmonaire
- Status de l'appareil génital
 - Installation (vessie vide, fesses dépassant les bords de la chaise, bras long du corps, informations +++)
 - Inspection et palpation abdominale (insister bas abdomen, loges rénales, ggl. inguinaux)
 - Inspection des OGE (mettre des gants, demander d'écarter les cuisses, toucher cuisse avec dos de la main)
→ inspecter vulve, vestibule (en écartant les grandes lèvres), ad. Valsalva pour prolapsus, région anale
 - Palpation des glandes
 - Glandes para-urétrales (2 phalanges distales dans le vagin, appuyer vers le haut, retirer avec pression)
 - Glandes vulvo-vaginales de Bartholin (pincement de la grande lèvre avec index dans vagin)
 - Examen su spéculum
 - Palpation bimanuelle de l'utérus
 - Palpation recto-vaginale
 - Palpation rectale

Status de l'épaule

Inspection :

- Observer le patient se déshabiller
- Inspection des épaules (devant, derrière, dessus) → déformations, asymétries, amyotrophie, cutané, etc.

Palpation :

- Palpation superficielle à la recherche d'une chaleur cutanée ou d'une douleur provoquée
- Palpation des os et des articulations
 - Sternum
 - Art. sterno-claviculaire
 - Clavicule → en particulier, rechercher une touche de piano
 - Art. acromio-claviculaire
 - Tête de l'humérus
 - Processus coracoïde
 - Épine scapulaire
- Palpation des muscles à la recherche d'une amyotrophie ou d'une contracture

Mobilisation :

- Flexion-extension en actif et en passif
- Abduction et adduction en actif et en passif
- Rotation externe en actif et en passif
- Demander d'aller toucher son omoplate contro-latérale (en passant derrière le dos, par le haut et par le bas)

Testing spécifique :

- Recherche de conflit → arc douloureux entre 60 et 120° de flexion de l'épaule
 - Test de Neer (tenir la scapula et lever le bras du patient)
 - Test de Hawkins (épaule à 90°, coude à 90°, appuyer sur l'avant-bras)
- Coiffe des rotateurs
 - Sus-épineux = test de Jobe (bras en abduction, 30° en avant, pouces vers le bas, appuyer dessus)
 - Sous-épineux = RE contre résistance
 - Petit rond = manœuvre de Patte (comme quand on prête serrement, puis pousser la main vers l'avant)
 - Subscapulaire = lift-off de Gerber (main dans le dos, décoller la main, maintenir la position)
 - Autres
 - Belly press test → demander au patient d'appuyer sur son ventre avec ses mains (coude en arrière?)
 - Signe du Portillon → retour automatique suite à une RE passive si déficit sous-épineux et petit rond
 - Signe du Clairon → patient élève le coude en amenant la main à sa bouche (déficit rotateurs externes)
- Testing du biceps brachial
 - Palm-up test (bras tendu, paume vers le haut, appuyer sur l'avant bras → douleurs?)
- Laxité et instabilité (instabilité = subjectif, laxité = objectif)
 - Laxité de l'articulation gléno-humérale
 - Laxité antéro-postérieure (rechercher un tiroir en tenant le moignon de l'épaule)
 - Laxité inférieure (empaumer le coude et le tirer vers le bas → dépression face externe deltoïde?)
 - Instabilité
 - Appréhension antérieure (comme pour Patte, en poussant la tête humérale vers l'avant)
 - Appréhension postérieure (patient touche par devant l'autre épaule, pousser le coude vers l'arrière)

Status du coude

Inspection → déformation, asymétrie, amyotrophie, tuméfaction articulaire, défauts cutanés, etc.

Palpation :

- Palpation superficielle
 - Recherche une différence de chaleur cutanée (inflammation)
 - Recherche de nodules ou de tophus goutteux au niveau ulnaire
 - Recherche d'une tuméfaction au niveau de l'olécrâne
- Palpation profonde
 - Palpation de l'épicondyle latéral (→ épicondylite latéral / tennis elbow)
 - Palpation de l'olécrane (→ enthésite du triceps)
 - Palpation de l'épicondyle médial
 - Palpation du trajet du nerf ulnaire à la recherche d'un canal cubital
 - Palpation du nerf médian et du radius au niveau antérieur
- Pouls brachial
- Recherche d'un épanchement / synovite au niveau de l'articulation intra-articulaire du coude

Mobilisation :

- Flexion-extension en actif et en passif (récurvatum 2-15° en extension)
- Pronation-supination

Testing spécifiques :

- Pour la recherche d'une épicondylite latérale (tennis elbow)
 - Palpation de l'épicondyle latéral à la recherche d'une douleur
 - Palpation de l'épicondyle latéral avec le poignet en extension
- Pour la recherche d'une épicondylite médiale (golfer elbow)
 - Palpation de l'épicondyle médial à la recherche d'une douleur
 - Palpation de l'épicondyle médial avec le poignet en flexion

Status de la main

Inspection :

- Rechercher asymétrie, déformations, tuméfactions, amyotrophie, défauts cutanés, défauts de perfusion
- Inspecter la face dorsale puis la face palmaire de la main
- Recherche des anomalies d'axes (déviation radiale sur Pouteau-Coles, déviation ulnaire sur PR, déviation dorsale, déviation palmaire, désaxation des doigts)

Palpation :

- Palpation des structures dorsales
 - Palpation superficielle à la recherche d'une chaleur ou d'une froideur cutanée
 - Palpation du styloïde radial et ulnaire, des os du carpe (scaphoïde +++), des métacarpes, des articulations MP, IPP, IPD et finalement de l'articulation trapézo-métacarpienne ainsi que de la tabatière anatomique → bien insister sur le radius distal et le scaphoïde !
 - Palpation des tendons extenseurs
- Palpation des structures palmaires
 - Rechercher une amyotrophie thénar et hypothénar ainsi qu'une induration de l'aponévrose palmaire
 - Palpation du styloïde radial et ulnaire, des os du carpe (scaphoïde +++), des métacarpes, des articulations MP, IPP, IPD et finalement de l'articulation trapézo-métacarpienne
 - Palpation des tendons fléchisseurs (en flexion puis en extension du poignet)

Mobilisation :

- Fermer le poing
- Écarter les doigts
- Mettre les mains comme lorsqu'on prie
- Évaluer la force de la main en demandant au patient de retenir nos doigts dans sa main
- Mobilité active et passive du poignet
 - Flexion-extension
 - Inclinaison radiale et ulnaire
 - Pronation et supination
- Mobilité active et passive des doigts
 - Flexion et extension
 - Abduction
- Mobilité active et passive du pouce
 - Articulation trapézo-métacarpienne
 - IPP/IPD
 - Mouvement d'opposition
- Test de l'étreinte (Gänslén) → compression latérale des MP

Testing spécifique :

- Pour rechercher une tendinite
 - Palpation du tendon concerné à la recherche d'une douleur / crépitation
 - Test de Finkelstein (pouce entre les doigts puis inclinaison ulnaire) → douleur = De Quervain
- Pour rechercher un tunnel carpien
 - Anamnèse → paresthésie nocturne de la face latérale de la main, engourdissement matinal, etc.
 - Rechercher une perte de sensibilité (paume latérale, D1, D2, D3, D4r)
 - Rechercher une parésie de l'abducteur du pouce ainsi qu'une amyotrophie thénar
 - Test de Tinel
 - Test de Durkan
 - Test de Phalen (1 minute)

Complément – CAT en cas de plaie palmaire :

- Sensibilité → toujours toucher les 2 bords de chaque doigt pour tester la sensibilité
 - N. médian (D1, D2, D3, D4r)
 - N. ulnaire (D4u, D5)
 - N. radial (face dorsale de la main)
- Vascularisation
 - Couleur + température cutanée de la main et des doigts
 - TDR
- Tendons
 - Demander de serrer le poing
 - Tester la flexion-extension de tous les doigts séparément, en particulier du majeur en bloquant le reste

Status du rachis et de l'articulation sacro-iliaque

Inspection :

- Inspection frontale → lésions, touffe de poils (spina bifida), asymétrie / scoliose, ceintures, MI
- Inspection sagittale → lordose cervicale, cyphose thoracique, lordose lombaire

Palpation :

- Palpation de la musculature para-vertébrale, symétriquement → rechercher des contractures
- Percussion des vertèbres avec le poing à la recherche d'une douleur

Mobilisation :

- Mobilité de la colonne cervicale → flexion-extension, inclinaisons latérales, rotations
- Mobilité de la colonne lombaire
 - Flexion-extension en mesurant la distance doigts-sol
 - Inclinaisons latérales
 - Rotations

Testing spécifique :

- Test de Schober → placer pouce sur L5 (L4 = niveau des épines iliaques) et index 10 cm au-dessus ; à la flexion, la distance devrait augmenter d'au moins 4 cm
- Test de Lasègue → sciatalgie L5-S1 ?
- Test de Lasègue inversé (soulèvement de la cuisse, jambe fléchie) → cruralgie L3-L4 ?
- Test de FABER (hanche en flexion, abduction et rotation externe, puis pression sur le genou) → anomalies des articulations coxo-fémorales et sacro-iliaques ?
- Test de Mennel (patient en décubitus latéral, prend la jambe vers le lit dans ses mains, extension autre jambe)

Status de la hanche

Inspection :

- Observer le patient qui se déshabille et la marche du patient, à la recherche d'une boiterie
- Inspection dorsale de la ceinture pelvienne (asymétrie, hauteur, déformations, etc.)
- Inspection de face de la ceinture pelvienne, patient couché (y.c. différence de longueur des MI)

Palpation :

- Pouls fémoral
- ADP inguinales
- Palpation des structures antéro-latérales → crête iliaque, grand trochanter, etc.
- Palpation des structures postérieures (sur le ventre) → crête iliaque, grand trochanter, mm. fessiers, sciatique

Mobilisation :

- Flexion-extension active et passive (pour l'extension, patient en décubitus latéral)
- Abduction-adduction
- RE + RI → prendre le genou et amener la jambe vers l'intérieur (RE) et vers l'extérieur (RI)

Testing spécifique :

- Test de FABER (hanche en flexion, abduction et rotation externe, puis pression sur le genou) → anomalies des articulations coxo-fémorales et sacro-iliaques ?
- Test de Thomas (rechercher un flexum de la hanche, donc une jambe pas bien à plat sur la table d'examen ; demander au patient de saisir la jambe contro-latéral pour lever un masquage dû à une hyperlordose)
- Test de Trendelenburg (demander de se mettre sur un pied et observer la symétrie)

Examen de la marche

- 1) Demander au patient de faire quelques pas et de revenir
- 2) Demander au patient de faire un aller-retour, aller sur la pointe des pieds, retour sur les talons
- 3) Rechercher un Trendelenburg et une boiterie de Duchenne (~ Trendelenburg dynamique bilatéral)

Status du genou

Inspection :

- Inspection de la démarche du patient
- Inspection debout → observation des MI, rechercher varus-valgus, creux poplité
- Inspection couché → asymétrie, déformation, amyotrophie, tuméfaction, défauts cutanés
- (Mesure de la distance intercondylienne et intermalléolaire)

Palpation :

- Palpation superficielle (différence de température entre les genoux, douleurs)
- Palpation des structures ostéo-articulaires
 - TTA
 - Rotule avec bords supérieur, inférieur, médial, latéral
 - Condyles fémoraux interne et externe
 - Interligne articulaire
 - Tête de la fibula
- Palpation des structures musculaires
 - Quadriceps
 - Tendons (notamment tendon rotulien)
- Palpation des structures ligamentaires (LLI, LLE)
- Palpation des ménisques interne et externe au niveau de l'interligne articulaire
- Recherche un épanchement par signe du glaçon (appuyer avec les 2 mains pour amener le liquide vers le genou, puis appuyer sur la rotule avec un doigt)
- Recherche d'un flexum du genou
 - Soulever les 2 pieds en les calant contre soi, appuyer sur les tibias
 - Observer la hauteur des 2 talons lorsque le patient est sur le ventre avec les pieds en-dehors du lit

Mobilisation :

- Flexion-extension active et passive du genou

Testing spécifique :

- Testing ligamentaire
 - Laxité dans le plan frontal → effectuer des mouvements de varus + valgus en tenant la cuisse et en appuyant sur la jambe, une fois avec la jambe tendue et une fois avec le genou fléchi à 30° (laxité en F-E = entorse grave avec LL et LC ; laxité en flexion uniquement = entorse bénigne, LL)
 - Laxité dans le plan sagittal
 - Tiroir antérieur (genou fléchi, s'asseoir sur le pied, tirer le genou en avant pour tester le LCA)
 - Tiroir postérieur (idem mais en tirant la jambe vers l'arrière pour tester le LCP)
 - Test de Lachman (prendre la cuisse d'une main, la jambe proximale de l'autre, faire aller-retour)
- Testing méniscal
 - Rechercher une douleur méniscale à la palpation de l'interligne articulaire en flexion
 - Test de McMurray (saisir le pied du patient, genou fléchi)
 - Ménisque interne → faire une RE du pied en palpant l'interligne articulaire interne ± F-E
 - Ménisque externe → faire une RI du pied en palpant l'interligne articulaire externe ± F-E
 - Grinding test (genou contre table, appuyer sur le pied en faisant des mouvements de RI/RE)
- Testing rotulien
 - Test de Smilie → déplacement latéral de la rotule du patient (positif si douleur au bord interne)

Status de la cheville et du pied

Inspection :

- Inspection en charge (pied plat, déformation, arrière de la cheville (léger valgus?))
- Demander de se mettre sur la pointe des pieds
- Demander au patient de marcher et observer la mécanique de la cheville et du pied
- Patient couché → inspection détaillée de la cheville et du pied, y.c. plante du pied et orteils

Palpation :

- Pouls tibial postérieur, pouls pédieux
- Palpation superficielle pour rechercher une chaleur cutanée
- Palpation de la cheville et de l'arrière-pied
 - Malléoles interne et externe
 - Talus
 - Calcanéus
 - Articulation talo-crurale et sous-talienne
 - Ligaments collatéraux interne et externe
 - Tendons des extenseurs, tendon tibial postérieur, tendon tibial antérieur, tendon d'Achille
 - Fascia plantaire postérieur (sous le pied)
- Palpation du médio-pied
 - Métatarses, en particulier tête du 5^e
 - Tendons des extenseurs
 - Fascia plantaire
- Palpation de l'avant-pied
 - Articulations MP, IPP et IPD
 - Phalanges
 - Rechercher un appui douloureux au niveau du fascia plantaire antérieur
- Test de Gänslén (étréinte) au niveau des MP

Mobilisation :

- Flexion-extension active et passive de la cheville
- Inversion-éversion active et passive de la cheville
 - En passif, tenir la cheville et faire bouger le talon
 - En passif, tenir le talon et faire bouger l'avant-pied
- Évaluer l'articulation de Lisfranc devant être quasiment immobile
- Évaluation de la mobilité active et passive des articulations MP et IP

Testing spécifique :

- Rechercher une solution de continuité au niveau du tendon d'Achille
- Test de Thompson (compression latérale du bas du mollet, patient sur le ventre)

GALS

Anamnèse :

- 1) Douleurs ou raideur au niveau des muscles, des articulations ou du dos ?
- 2) Est-ce que vous arrivez à vous habiller et déshabiller sans difficultés ?
- 3) Est-ce que vous arrivez à monter et descendre les escaliers sans difficultés ?

Status :

- Gait → demander de marcher en ligne droite, de se retourner et de revenir, idem pointe/talon
- Inspection
 - Postérieure (épaules, scapula, crêtes iliaques, colonne, creux poplité, jambes, pieds)
 - Latérale (lordose, cyphose, genou)
 - Antérieure avec les mains en supination ! (MS, MI, thorax, abdomen)
- De la tête au pieds
 - Nuque et ATM
 - Demander de toucher l'épaule avec l'oreille
 - Demander d'ouvrir grand la bouche et de déplacer la mâchoire
 - Épaule
 - Demander de placer ces mains derrière la tête et de reculer les coudes
 - Mains
 - Observation des mains
 - Mouvement de pro-supination
 - Demander de serrer les poings, demander de retenir ses 2 doigts en faisant le poing
 - Demander de toucher tous les doigts avec son pouce
 - Test de Gänslen
 - Dos
 - Test de Schöber
 - Hanche et genou
 - Flexion de la hanche et flexion du genou
 - RE + RI de la hanche
 - Test du glaçon
 - Pieds
 - Observation attentive des pieds
 - Test de Gänslen

URGENCE

ABCDE :

- A : parler avec le patient, libérer les VA ± Guedel ± minerve
- B : inspection, auscultation, oxymétrie, ad. O2 si nécessaire
- C : FC, TA, TRC, pouls, ad. voies veineuses et perfusion si nécessaire
- D : GCS, pupilles, recherche d'un hémisynonyme
- E : log-roll, température

SAMPLE :

- Symptômes à caractériser +++ (début, facteurs déclenchants, localisation, qualité, sévérité, évolution)
- Allergies
- Médicaments
- Past-illness & Pregnancy
- Last meal
- Events (événements ayant mené à la situation d'urgence)

Suspicion d'infarctus :

- ABCDE
- Anamnèse : caractériser la plainte, rechercher FRCV, ATCD
- Ad. ECG
- Ad. médication pour soulager la douleur
- Status CV
- Ad. cardiologie (coronarographie vs. thrombolyse)

PEC de la dyspnée :

- ABCDE
- Anamnèse ciblée
- Orientation du DD (IC/OAP, pneumonie, EP, pneumothorax, asthme/BPCO décompensé, pleurésie, panique)
- Status pulmonaire
- Status CV

PEC des douleurs abdominales :

- Rechercher red-flags (FR > 20, SaO2 < 90 %, FC > 100 ou < 50, TA < 90/60, T° > 38° ou < 36°, GCS < 12)
- Anamnèse ciblée → EG, N/V, dysphagie, appétit, perte de poids, soif, transit, urines, gynéco, ATCD
- Examen clinique
- Paraclinique selon suspicion, dans tous les cas β-hCG, FSS, glucose, CRP, Na, K, créatinine ± ASP/US/CT
- Traitement initial précoce (oxygène, hydratation, analgésie)

Urgences pédiatriques :

- TEP → apparence générale, respiration, hémodynamique (Apparence, Breathing, Circulation)
 - ABCDE
 - SAMPLE
 - Rechercher red-flags
-

Enfant/Adulte		
Activité	Score	Description
Ouverture des yeux	4	Spontanée
	3	À la demande
	2	À la douleur
	1	Aucune
Réponse verbale	5	Orientée
	4	Confuse
	3	Paroles inappropriées
	2	Sons incompréhensibles
	1	Aucune
Réponse motrice	6	Obéit aux commandes
	5	Localise à la douleur
	4	Retrait à la douleur
	3	Flexion anormale (décortication)
	2	Extension anormale (décérébration)
	1	Aucune

Status psychiatrique

Anamnèse :

- Anamnèse actuelle
 - Explorer les plaintes et les symptômes
 - Investiguer le contexte (début, durée, intensité, évolution, facteurs modifiants / déclenchants)
 - Explorer les répercussions sur la vie du patient (sphères sociales, familiales, professionnelles)
- ATCD psychiatriques
 - Personnels → ATCD d'hospitalisation, de suivi psy, de traitements psychotropes
 - Familiaux
- ATCD médicaux
 - Affections somatiques, traitements, allergies
 - Alcool, tabac, drogues
- Anamnèse socio-professionnelle et familiale
 - Profession / activité / revenu (AI, chômage, etc.)
 - Mode et lieu de vie (seul, famille, couple, SDF, etc.)
 - Entourage social et familial (liens familiaux, relations amicales et sentimentales, relations sexuelles, etc.)
 - Activités de la vie quotidienne et loisirs
- Questions spécifiques pour DD
 - Orientation ?
 - Concentration et attention ?
 - Idées délirantes ?
 - Hallucinations ?
 - Pensées imposées ?
 - Humeur ? anhédonie ?
 - Anxiété, tension interne, obsessions-compulsions ?
 - Phobies ?
 - Idées suicidaires ?
 - Hétéroagressivité ?
 - Troubles somatiques → sommeil, appétit, troubles GI, troubles cardio-respiratoires
- UDR :
 - Urgence → scénario suicidaire, degré d'envahissement des idées, degré de planification dans le temps
 - Danger → accessibilité et létalité du moyen envisagé
 - Risque suicidaire
 - FR épidémiologique → ATCD de tentamen, H>F, tr. psychiatriques, substances, isolement, événements de vie négatifs, maladie chronique, affection somatique invalidante
 - Signes d'alerte / facteurs précipitant → pertes, échecs, humiliation, violences, désespoir, rage, comportements à risque, retrait, anxiété, instabilité de l'humeur, agitation

Évaluation des fonctions cognitives

1) Orientation

- Date du jour (jour, mois, année) ?
- Quel jour de la semaine ?
- Dans quel bâtiment sommes-nous ?
- Dans quelle ville sommes-nous ?

2) Apprentissage

- Demander au patient de retenir 3 mots → clé, citron, ballon
- Faire un rappel immédiat
- Faire un rappel différé plus tard

3) Attention et calcul

- Demander de compter de 7 en 7 en descendant à partir de 100
- Demander d'épeler le mot monde à l'envers

4) Rappel → rappel différé des 3 mots

5) Langage

- Montrer un crayon / stylo et demander le nom de l'objet, faire pareil avec un autre objet
- Demander au patient de prendre une feuille, de la plier en deux et de la jeter par terre
- Donner une feuille de papier où il est écrit « fermez les yeux » et lui dire de le faire
- Demander au patient d'écrire une phrase complète

6) Praxie → demander de recopier un dessin

Entretien motivationnel

Introduction :

- Demander la permission → seriez-vous d'accord pour que l'on discute un moment de ?
- Parlez-moi un peu de votre situation (ex. de votre consommation, du problème, etc.)

Connaissances :

- Identifier les connaissances du patient → que savez-vous par rapport à ?
- Identifier les besoins du patient → que souhaiteriez-vous savoir en plus par rapport à ... ?
- Est-ce que vous seriez d'accord que je vous donne davantage d'informations ?
- Donner des informations supplémentaires
- Qu'est-ce que vous en-pensez ? Est-ce que cela a été utile pour vous ?

Avantages et inconvénients du changement :

- Qu'est-ce qui vous semble difficile ? qu'est-ce qui vous dérange ? parlez moi de vos craintes ?
- Qu'est-ce qui va bien dans cette situation ? quels sont les avantages de la situation ?
- Imaginez que vous ayez déjà pris la décision de ..., quels seraient les gains et bénéfices potentiels ?
- Qu'est-ce qui serait différent par la suite si les choses changeaient de cette manière ?
- De 0 à 10, comment vous situez vous par rapport à cette volonté de changement ? pourquoi ?
- Si vous décidez de faire ce changement, à quel point vous faites vous confiance de 0 à 10 pour réussir ?
- Comment votre confiance pourrait-elle se renforcer ?

Plan pour la suite :

- J'ai compris que, cela montre que
- Que voulez faire ?
- Je vous propose de faire

Annonce de mauvaise nouvelle

Structure de base :

- 1) Comment allez-vous ? Je viens discuter un moment avec vous, êtes-vous confortable ?
- 2) Qu'avez-vous compris de la situation jusqu'à présent ?
- 3) Faire un résumé du contexte
- 4) Quel niveau d'information souhaitez-vous ? Voulez vous beaucoup de détails ou une vue globale ?
- 5) J'aurais aimé vous donner de bonnes nouvelles, mais la situation est malheureusement plus compliquée
- 6) Les résultats des examens ont confirmé
- 7) Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous annoncer ?
- 8) Comment vous sentez-vous par rapport à cette annonce ?
- 9) Je vois que vous êtes, ce qui est tout à fait normal face à cette situation, je comprends votre ressenti
- 10) Sachez que vous ne resterez pas seul face à cela, nous allons explorer ensemble tout ce qui est possible d'entreprendre dans votre situation
- 11) Stratégie de suivi :
 - Demander au patient s'il est prêt à parler de la suite
 - Demander au patient ce qu'il compte faire pour faire face
 - Demander si le patient a des soutiens (famille, amis, etc.)
 - Aborder les stratégies de traitement
- 12) Demander au patient de faire une synthèse de sa situation
- 13) Synthèse finale → synthèse, demander si questions, fixer RDV proche et offrir une disponibilité téléphonique, remettre des informations écrites si disponibles et demander au patient ce qu'il compte faire le reste de sa journée...

Transmission IPASS et présentation de cas

Transmission de cas traditionnelle	Transmission IPASS
Sexe, nom, âge	Identification de la gravité (stable, à surveiller, instable) (spécifier)
Motif de consultation / plainte principale	Patient (motif et ATCD, évolution, plan de soins)
ATCD liés à la problématique	Actions (actions à entreprendre, temporalité, responsabilité)
Principaux éléments à l'anamnèse	Situations (à quoi prêter attention, attitude selon situations)
Principaux éléments à l'examen physique	Synthèse (par le receveur qui pose des questions)